

LAPORAN AKHIR
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal
Periode ATA 2023/2024



PENINGKATAN KAPASITAS TENTANG MEKANISME PERSALINAN NORMAL
DI TPMB BIDAN ISMI SANTI S.ST, CIMANGGIS, KOTA DEPOK

Oleh :

Ketua Anggota	:	Pujiati M.Keb	(0327037901)
		Ambariani, M.Keb	(0304107801)
		Rini Damayanti, S.ST., MPH	(0323118703)

UNIVERSITAS GUNADARMA
2024

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Peningkatan Kapasitas Tentang
Mekanisme Persalinan Normal
2. Nama Mitra Program : TPMB bidan Ismi Santi, S.ST Depok,
Jawa Barat
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Pujiati, S.Si.T., M.Keb
 - b. N I D N : 0327037901
 - c. Program Studi : Pendidikan Profesi Bidan
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota I/ Bidang Keahlian : Ambariani. S.ST., M.Keb/ Kebidanan
Rini Damayanti, S.ST., MPH
/Kebidanan.Kesehatan Masyarakat
 - c. Mahasiswa yang Terlibat : 2 orang
5. Lokasi Kegiatan / Mitra
 - a. Wilayah Mitra / (Desa/Kecamatan) : Kecamatan Cimanggis
 - b. Kabupaten/Kota : Depok
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 3 km
6. Luaran yang dihasilkan : Publikasi ilmiah pada jurnal ber-
ISSN/ Prosiding,
Tahun ke-1 Target : Tidak Ada
-Publikasi pada Media Masa Cetak/
Online/
Respiratory PT, Tahun ke-1 Target :
Tidak Ada
-Peningkatan Daya Saing
(Peningkatan Kualitas,

Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang,
 Jasa,
 Diverifikasikan Produk, atau Sumber
 Daya
 Lainnya), Tahun ke-1 Target : Ada
 -Peningkatan Penerapan Iptek di
 Masyarakat
 (Mekanisasi, IT dan Manajemen),
 Tahun ke-1 Target
 : Tidak Ada
 -Perbaikan Tata Nilai Masyarakat
 (Seni, Budaya,
 Sosial, Politik, Keamanan,
 Ketenteraman,
 Pendidikan, Kesehatan), Tahun ke-2
 Target : Ada
 -Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau
 System,
 Produk/Barang, Tahun ke-1 Target:
 Tidak Ada
 -Hak Kekayaan Intelektual (Paten,
 Paten Sederhana,
 Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia
 Dagang, Desain
 Produk Industri, Perlindungan
 Varietas Tanaman,
 Perlindungan Desain Topografi
 Sirkuit Terpadu)

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : |
| 8. Biaya Total | : Rp. 2.000.000 |
| a. DPRM | : Rp. 0 |
| b. Sumber Lain | : Rp. |

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Pengusul

(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)

NIP. 930391/NIDN: 0326057004

(Pujiati, S.SiT., M.Keb)

0327037901

DAFTAR ISI

PROGRAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	I
DAFTAR ISI	I
RINGKASAN	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Analisis Situasi	2
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra	2
	3
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	
2.1 Solusi	3
2.2 Target Luaran	3
	5
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
3.1 Metode Pelaksanaan	5
3.2 Rencana Kegiatan	6
	7
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	7
4.2 Kepakaran Tim	8
4.2.1 Tim Pengusul	8
4.2.2 Tim Pelaksana	8
	9
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
5.1 Hasil	9
5.2 Luaran.....	9
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	10
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	11
7.1 Kesimpulan	11
7.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran 1. Peta Lokasi	
Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra	
Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra (dengan materai Rp. 10.000)	
Lampiran 4. Jadwal Kegiatan	
Lampiran 5. Anggaran Biaya	
Lampiran 6. Tim Mahasiswa Pelaksana	
Lampiran 7. Luaran yang dicapai (photo Hasil Kegiatan,/ Publikasi/ Video Kegiatan)	

RINGKASAN

Menurut World Health Organization (WHO), kehamilan adalah proses selama sembilan bulan atau lebih dimana seseorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Sedangkan Persalinan menurut WHO adalah pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) yang telah cukup bulan (37 - 42 minggu) atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam tanpa adanya komplikasi pada persalinan. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang matang (37-42 minggu) melalui vagina ibu, tanpa komplikasi, dengan presentasi belakang kepala, dan berlangsung dalam waktu kurang dari 18 jam. Proses ini dibagi menjadi 4 kala yaitu Kala I: Pembukaan Serviks (Lama: 12-24 jam) Terdiri dari 3 fase: Fase Laten (1-3 cm), Fase Aktif (4-7 cm), Fase Transisi (8-10 cm). Kala II: Pengeluaran Janin (Lama: 30-60 menit). Kala III: Pengeluaran Plasenta (Lama: 15 menit). Kala IV: Pemulihan (Lama: 2 jam). Mekanisme Persalinan: Penurunan Janin, Penyesuaian Diri, Fleksi Kepala, Desensus, Rotasi Luar, Ekstensi Kepala, Rotasi Dalam, Ekspulsi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persalinan: Kekuatan His, Jalan Lahir, Janin, Kekuatan Ibu.

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dalam 3 tahapan yaitu : tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan persiapan meliputi pengurusan ijin, observasi lapangan, pengumpulan bahan dan persiapan materi serta koordinasi dengan pihak terkait. Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pendidikan kesehatan mengenai melakukan pemeriksaan ibu hamil, persiapan persalinan dan tahap-tahap persalinan. Tahapan ketiga adalah tahap akhir yang meliputi interpretasi hasil dan penyusunan laporan.

Kata Kunci: Kehamilan, Persiapan Persalinan, Ibu hamil, Persalinan Sehat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persalinan merupakan proses fisiologis yang dialami oleh semua wanita hamil dengan usia kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) untuk melahirkan janin, plasenta, dan selaput ketuban melalui vagina. Proses ini merupakan puncak dari perjalanan kehamilan yang penuh dengan persiapan dan penantian. Ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya AKI dan AKB. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan/ upaya untuk mengurangi angka AKI, salah satunya yaitu dengan program ANC terpadu dan penerapan P4K yang dilakukan secara komprehensif sebagai persiapan dalam menghadapi persalinan. Namun dalam penerapannya angka AKI masih tinggi, untuk itu diperlukan perencanaan persalinan dengan menggunakan birth plan sebagai upaya tambahan dalam mempersiapkan kelahiran bayi agar ibu hamil siap dalam menghadapi persalinan. Kesiapan persalinan menjadi salah satu penentu pelancar persalinan. Kesiapan persalinan meliputi kesiapan fisik dan mental.

Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi persalinan antara lain persiapan fisik dengan membuat rencana persalinan (birth plan), tempat persalinan, penolong persalinan, transportasi, pendamping persalinan, pengambil keputusan, dana persalinan, barang-barang keperluan ibu dan janin, serta keperluan fisik lainnya. Sedangkan kesiapan mental dalam menghadapi persalinan antara lain ibu siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi selama proses persalinan, semangat dan percaya diri, sabar, dan tenang dalam menghadapi persalinan

Meskipun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun masih banyak permasalahan yang ditemukan terkait komplikasi saat persalinan antara lain kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, placenta previa, Intra Uterine Fetal Death (IUFD). Timbulnya berbagai permasalahan yang terjadi saat persalinan, pemerintah selalu berupaya menurunkan angka kematian ibu dengan melakukan perluasan pelayanan kesehatan berkualitas melalui pelayanan obstetrik yang komprehensif seperti penyediaan fasilitas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) (Kemenkes RI, 2013). Tata laksana ideal persalinan memerlukan dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, persalinan harus dikenali sebagai proses fisiologis normal yang sebagian besar perempuan mengalaminya tanpa komplikasi. Kedua, komplikasi intrapartum yang muncul secara cepat dan tiba-tiba harus diantisipasi. Petugas kesehatan harus

bisa membuat setiap perempuan yang melahirkan dan keluarga merasa nyaman dan memastikan keselamatan ibu serta neonatus jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi (Cunningham et al, 2006).

Petugas kesehatan harus memiliki sikap empati dan kesabaran untuk mendukung calon ibu yang melahirkan dan keluarga, selain itu juga pemberi perawatan dalam persalinan juga harus mampu memenuhi tugas diantaranya mendukung wanita; pasangan dan keluarga selama proses persalinan, mengobservasi saat persalinan berlangsung; memantau kondisi janin dan kondisi bayi setelah lahir; mengkaji faktor resiko; mendeteksi masalah sedini mungkin, melakukan intervensi minor jika diperlukan seperti amniotomi dan episiotomi; perawatan bayi baru lahir, merujuk ke tingkat perawatan yang lebih tinggi jika terjadi komplikasi (Tasnim et al, 2011). Sebagian besar wanita menyatakan bahwa kehadiran petugas kesehatan saat persalinan sangat penting karena mereka memberikan dukungan dan informasi terkait proses persalinannya. Wanita merasa bahwa bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan saat proses persalinan menimbulkan dampak yang positif diantaranya dapat menurunkan kecemasan, menurunkan rasa sakit, menghindari stres dan trauma saat persalinan.

1.2 Analisis Situasi

Saat ini, terdapat beberapa situasi yang berkaitan dengan mekanisme persalinan normal, yaitu:

- **Tingkat kematian ibu dan bayi saat persalinan masih tinggi:** Di Indonesia, angka kematian ibu (AKI) masih tergolong tinggi, yaitu 177 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Angka kematian bayi (AKB) juga masih tinggi, yaitu 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ini adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme persalinan normal, sehingga persalinan tidak ditangani dengan tepat.
- **Tingginya angka intervensi medis saat persalinan:** Di beberapa negara, termasuk Indonesia, terdapat kecenderungan untuk melakukan intervensi medis saat persalinan, seperti operasi caesar, tanpa indikasi medis yang jelas. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.
- **Kurangnya edukasi tentang persalinan normal bagi wanita hamil:** Banyak wanita hamil yang masih kurang memahami tentang mekanisme persalinan normal dan pilihan-pilihan yang tersedia untuk mereka. Hal ini dapat membuat mereka merasa cemas dan tidak berdaya saat menghadapi persalinan.

1.3 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait mekanisme persalinan normal, yaitu:

- **Kurangnya tenaga kesehatan yang terampil dalam menangani persalinan normal:**
Di beberapa daerah, terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang terampil dalam menangani persalinan normal, sehingga wanita hamil terpaksa melahirkan di tempat yang tidak memadai atau dengan bantuan tenaga kesehatan yang tidak terlatih.
- **Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat tentang persalinan normal:**
Banyak wanita hamil yang mendapatkan informasi tentang persalinan normal dari sumber yang tidak akurat, seperti media sosial atau cerita dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang salah tentang proses persalinan dan membuat mereka merasa cemas atau takut.
- **Stigma terhadap persalinan normal:** Di beberapa budaya, masih terdapat stigma terhadap persalinan normal, sehingga wanita hamil merasa tertekan untuk melahirkan dengan cara operasi caesar.

BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Untuk mengatasi permasalahan mitra terkait mekanisme persalinan normal, diperlukan beberapa solusi, yaitu:

- **Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan:** Tenaga kesehatan perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif tentang mekanisme persalinan normal dan cara menangani persalinan dengan aman dan efektif.
- **Meningkatkan edukasi tentang persalinan normal bagi wanita hamil:** Wanita hamil perlu mendapatkan edukasi yang akurat dan komprehensif tentang persalinan normal, pilihan-pilihan yang tersedia, dan bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi persalinan.
- **Mempromosikan persalinan normal:** Perlu dilakukan upaya untuk mempromosikan persalinan normal sebagai pilihan yang aman dan efektif bagi ibu dan bayi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye public awareness dan edukasi kepada masyarakat.
- **Melakukan penelitian tentang mekanisme persalinan normal:** Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme persalinan normal untuk meningkatkan pemahaman tentang proses fisiologis ini dan mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk membantu ibu hamil dan bayi selama persalinan.

2.2 Target Luaran

Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa publikasi ilmiah, publikasi media massa, dan rencana penelitian. Penjelasan terinci target luaran adalah sebagai berikut :

1. Publikasi Pada Media Massa

Rencana jangka pendek adalah pengirim laporan pelaksanaan kegiatan abdimas ke UG NEWS dan besar harapan kami apabila pengabdian masyarakat ini dapat dimuat di media massa nasional.

2. Rencana Penelitian

Rencana penelitian difokuskan pada evaluasi webinar dan intervensi yang diperlukan untuk menangani temuan masalah

Target adalah Pasien di TPMB BIDAN ISMI SANTI S.ST, Depok, Jawa Barat terangkum seperti dalam table 2.3 dibawah ini:



Menuju KEHAMILAN SERAT

Kehamilan 9 bulan, sejak pembuahan sampai persalinan sungguh merupakan proses yang luar biasa. Dengan kunjungan rutin ke provider, pilihan gaya hidup cerdas, dan sedikit perencanaan. Mama akan berada di "jalan" yang benar untuk membangun masa depan keluarga yang sehat.

START

Ketahui usia kehamilan dengan berpatokan pada tanggal hari pertama haid terakhir

MULAI KONTROL
RUTIN BULANAN

- ✓ Jadwalkan untuk pemeriksaan kehamilan pertama
- ✓ Cari bidan atau dokter yang menurut anda cocok

minggu 4-8



TIP:
JIKA MEMELIHARA
HEWAN, JAUHI
KOTORANNYA

minggu 9-13

Jika demam atau merasa nyeri, pilih obat dari bahan yang aman bagi kehamilan

TIP:
DISKUSIKAN PADA
DOKTER PERLU
TIDAKNYA
KONSELING
GENETIK

minggu 14-18

- ✓ Latihan kegel untuk menguatkan otot seputar jalan lahir.



Dokter mungkin menyarankan amniosentesis (pengambilan sampel cairan ketuban untuk deteksi kelainan genetik tertentu)

TRIMESTER 2

TIP:
USIA 35+

Dokter mungkin menyarankan amniosentesis (pengambilan sampel cairan ketuban untuk deteksi kelainan genetik tertentu)

Mama hamil dengan berat badan ideal perlu tambahan 300 kalori per hari



Rencanakan pola makan sehat dan minum suplemen (asam folat, zat besi).

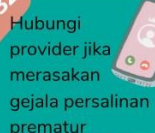
- ✓ Siap dengan pemeriksaan USG kehamilan trimester kedua
- ✓ Pertimbangkan untuk menyimpan darah tali pusat bayi di bank sel punca (stem cell) untuk pengobatan kanker dan kelainan tertentu

minggu 19-23

Mama separuh perjalanan!

minggu 24-27

minggu 28-32



Hubungi provider jika merasakan gejala persalinan prematur

- ✓ Ikuti kelas senam hamil atau kelas perawatan bayi.

Tanya provider, apakah perlu menjalani tes gula darah

- ✓ Pertimbangkan untuk ikut asuransi jiwa

TIP:
SIAPKAN DAFTAR
KEBUTUHAN BAYI
CAR SEAT BAYI,
KERETA DORONG,
POMPA ASI DLL.



Kontrol tiap 2 minggu lalu 1 minggu sekali

minggu 33-37

- ✓ Tur untuk melihat-lihat kamar perawatan bersalin nanti
- ✓ Pilih dokter anak atas rekomendasi provider

TRIMESTER 3

TIP:
SIAPKAN TAS BERSI
PERLENGKAPAN
YANG AKAN
DIBAWA KE TEMPAT
BERSALIN.



- ✓ Jika merasa stress, konsultasikan hal ini pada provider
- ✓ Baca buku/artikel tentang perawatan bayi baru lahir atau kiat menyusui

minggu 38-42

TIP:
WASPADAI
KONTRAKSI



Patuhi jadwal imunisasi dan kontrol kesehatan agar bayi senantiasa sehat

FINISH

Selamat si buah hati kini sudah di pelukan



Hari H

TIP:
BERPIKIR POSITIF
POSITIVE
VIBES



- ✓ Hubungi dokter/ bidan pendamping sebelum pergi ke tempat bersalin
- ✓ Bawa tas perlengkapan yang sudah disiapkan

AFIFAH TAUFIK
AULIA WULANDARI

Tabel 2.3
Rencana Capaian Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN/Prosiding jurnal Nasional	Tidak Ada
2.	Publikasi pada media massa cetak/online/repository PT	Tidak ada
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang dan jasa, diverifikasi produk, atau sumber daya lainnya	Ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamana, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
2.	Jasa : rekayasa sosial, metode atau system, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru TTG	Tidak Ada
4.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak Ada
5.	Buku Ber-ISSBN	Tidak Ada

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat kali ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan Mekanisme Persalinan Normal di TPMB BIDAN ISMI SANTI, S.ST , depok, Jawa Barat. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan kepada masyarakat (Abdimas) dari tim dosen Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Universitas Gunadarma, Mahasiswa kebidanan bekerjasama dengan TPMB BIDAN ISMI SANTI, S.ST, Depok, Jawa Barat.

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah penyuluhan Mekanisme Persalinan Normal agar memahami dan tidak takut menghadapi proses persalinan. Adapun rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat, ditunjukkan pada Gambar 1 meliputi tahapan rencana kegiatan dan metode kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan hasil dan pembahasan. Berdasarkan Gambar 1, tahapan pertama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi kegiatan dengan melaksanakan analisis situasi untuk menemukan prioritas permasalahan mitra. Tahap kedua yaitu identifikasi kebutuhan mitra untuk menemukan desain Solusi dan program kegiatan yang tepat Sasaran. Temuan program pada kegiatan ini melakukan Penyuluhan Pada pasien ANC di TPMB Bidan Ismi Santi, S.ST. Tahap ketiga, desain strategi penyuluhan dilakukan dengan mengumpulkan pasien ANC di ruang tunggu. Tahap keempat dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah rangkaian kegiatan penyuluhan kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pasien, mahasiswa dan dosen pendamping kegiatan. Bahan-bahan yang digunakan adalah media penyuluhan pada pasien ibu hamil. Tahap berikutnya merupakan tahap akhir pada metode pelaksanaan kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan partisipasi aktif mitra. Evaluasi pelaksanaan program bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan keberlanjutan program.

3.2 Rencana Kegiatan

Berdasarkan penjelasan terkait dengan implementasi solusi, maka pada tahapan ini adalah melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

2. Melakukan sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan analisis kebutuhan mitra
4. Melakukan persiapan pelaksanaan penyuluhan kesehatan
5. Melaksanakan penyuluhan tentang Mekanisme Persalinan Normal
6. Melakukan penyusunan laporan kegiatan dan menyusun jurnal
7. Menyerahkan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya menyosialisasikan penelitiandan pelayanan IPTEKS unggulan berguna bagi masyarakat secara luas. Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard,dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi bukureferensi yang sangat baik.
 - d. Unit Pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloit UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.

5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Rata-rata kepakaran tim pengusul adalah bidang Kesehatan Masyarakat dan Kebidanan. Sedangkan mahasiswa merupakan mahasiswa program studi S1 Kebidanan Universitas Gunadarma.

4.2.1 Tim Pengusul dan Pelaksana

NO	NAMA	SINTA ID	BIDANG ILMU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	HASIL KINERJA
1.	Pujiati	6801708	Kebidanan	Merencanakan kegiatan penyuluhan	Jadwal kegiatan
2.	Ambariani	6685734	Kebidanan	Merencanakan kegiatan penyuluhan	Jadwal kegiatan
3.	Rini Damayanti	6687516	Kebidanan, Kesehatan Masyarakat	Merencanakan kegiatan penyuluhan	Jadwal kegiatan
4.	Afifah Taufik	-	-	Melakukan kegiatan penyuluhan	Telah dilakukan penyuluhan
5	An Nisaa Raihani Kamto	-	-	Melakukan kegiatan penyuluhan	Telah dilakukan penyuluhan

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

Telah berhasil dibuat pengabdian kepada masyarakat dengan peningkatan kesehatan dalam siklus kehidupan manusia melalui pemberian informasi dan edukasi tentang Mekanisme Persalinan Normal telah tersampaikan pada peserta yaitu pasien ANC di TPMB bidan Ismi Santi, S ST, depok, Jawa Barat. Peserta memahami materi dan termotivasi dan tidak cemas menghadapi persalinan.

5.2 Luaran yang Dicapai

Telah berhasil diberikan peningkatan daya saing yaitu peningkatan sumber daya pemilik berupa penambahan wawasan tentang Mekanisme Persalinan Normal, Telah berhasil diberikan peningkatan penerapan iptek di masyarakat yaitu peningkatan upaya bersalin secara normal, menyingkirkan cemas dan gelisah dalam menghadapi persalinan normal.

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana pengabdian masyarakat tahap berikutnya mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kepada bayi baru lahir selama 0-6 bulan tanpa ada tambahan apapun dalam tubuh bayi. ASI (Air Susu Ibu) adalah salah satu sumber utama asupan bagi bayi yang sifatnya eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi usia 0-6 bulan. dalam fase ini sangat diperhatikan dengan benar tentang pemberian serta kualitas ASI yang diberikan, dikarenakan pada usia 0-6 bulan adalah usia emas bagi bayi dalam bertumbuh dan berkembang. Maka dari itu ada beberapa manfaat ASI eksklusif yang perlu diketahui bagi ibu yang sedang menyusui maupun yang akan menyusui.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Terjalannya hubungan Kerjasama mitra dalam Upaya peningkatan kapasitas mengenai mekanisme persalinan normal merupakan topik yang penting untuk terus disosialisasi dan sampaikan kepada ibu-ibu hamil yang akan melalui proses persalinan terutama di TPMB. Ny. Ismi Santi S.ST agar para calon ibu akan lebih siap dalam menghadapi proses persalinannya. Dengan melaksanakan rencana tahapan selanjutnya, diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mekanisme persalinan normal, sehingga dapat meningkatkan angka persalinan normal dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan.

7.2 Saran

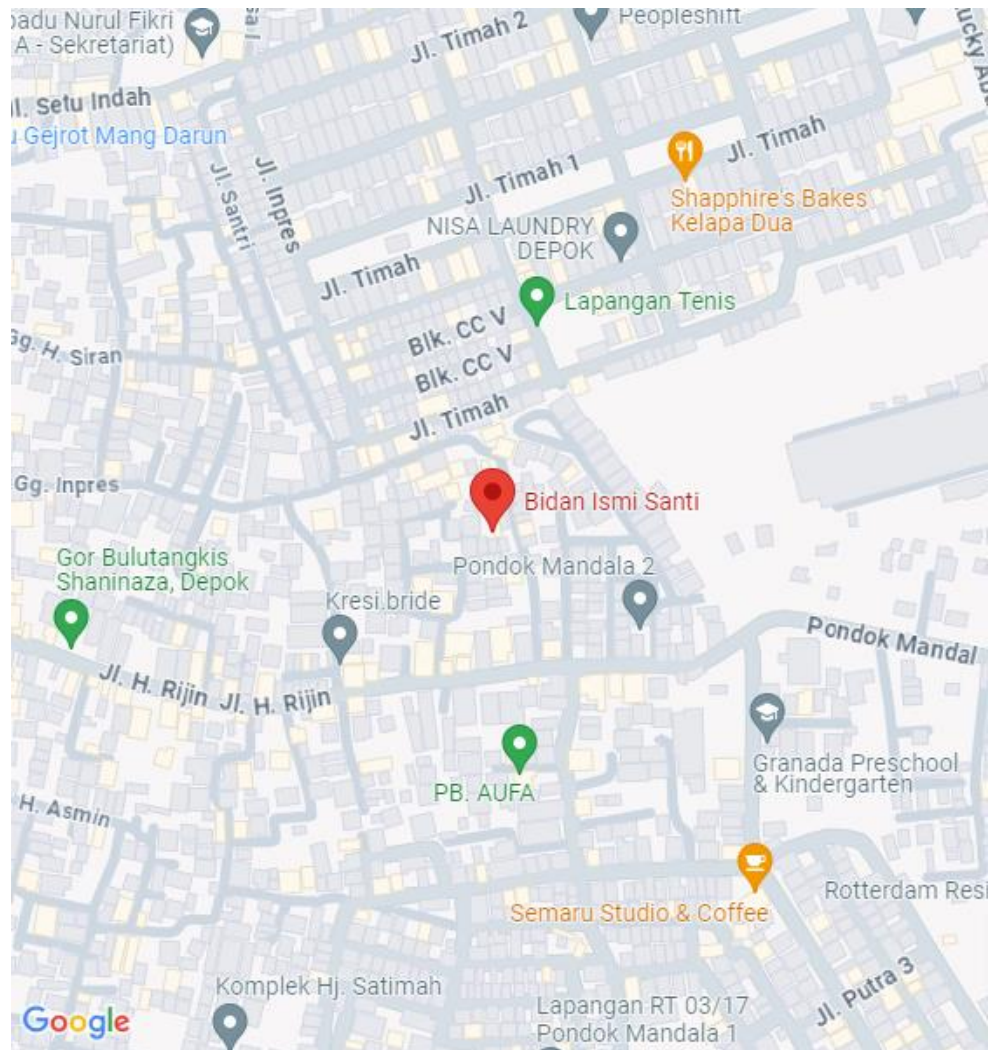
Perlu diadakan program kesehatan masyarakat tentang kelas ibu hamil secara berkesinambungan agar cakupan peserta lebih banyak dan bertambah jumlah peserta yang melibatkan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi dan Sunarsih, (2012). *Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan*. Salemba. Medika: Jakarta.
- Mufdillah, (2009). *Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil*. Yogyakarta: Mitra Cendikia offset.
- Wiknjosastro, (2010) Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Edisi 1, Cetakan 12, Jakarta : Bina Pustaka
- Mutmainnah AU, Johan H. *Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PETA LOKASI



LAMPIRAN 2. SURAT PERMINTAAN MITRA



BIDAN ISMI SANTI S.ST

Gg. Inpres No.133 RT.003 RW.011
Kelapa Dua Kel. Tugu Kec.Cimanggis
Depok 16951, Telp: 081398112549



SURAT PERMINTAAN MITRA **No: 02/ SM/VI/ 2024**

Kepada Yth,
Rektor Universitas Gunadarma
Up.
Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ismi Santi S.ST

Jabatan : Pemilik TPMB

Bidang : Kesehatan

Alamat : Gg. Inpres RT.03/11 No.133 Kelapa Dua, Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis

Mengajukan permintaan kepada Universitas Gunadarma untuk membantu kami dalam bentuk pemberian "Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Pada Ibu Hamil Terhadap Proses Persalinan". Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan dapat menambah pengetahuan tentang proses persalinan pada ibu hamil.

Demikianlah surat permintaan ini, atas perhatian dan kerjasama Universitas Gunadarma kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 3 Juni 2024
Pengelola TPMB

Bdn.Ismi Santi S.ST



LAMPIRAN 3. SURAT LAMPIRAN MITRA



BIDAN ISMI SANTI S.ST

Gg. Inpres No.133 RT.003 RW.011
Kelapa Dua Kel. Tugu Kec.Cimanggis
Depok 16951, Telp: 081398112549



SURAT KETERANGAN MITRA

No: 01/ SM/VI/ 2024

Kepada Yth,
Rektor Universitas Gunadarma
Up.
Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
Di Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Ismi Santi S.ST
Jabatan : Pemilik TPMB
Bidang : Kesehatan
Alamat : Gg. Inpres RT.03/11 No.133 Kelapa Dua, Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis

Menyatakan bahwa nama tersebut di bawah ini telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara terprogram dalam bentuk "Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Pada Ibu Hamil Terhadap Proses Persalinan di TPMB Ismi Santi Depok" khususnya bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat pada periode juni- Agustus 2024 dengan :

Ketua Tim Pengusul	Nama	Bidang Ilmu
	Pujiati,S.Si.T.,M.Keb	Kebidanan
Anggota Pelaksana	Ambariani,SST.,M.Keb	Kebidanan
	Rini Damayanti, S.ST.,MPH	Kebidanan, Kesehatan Masyarakat
	Afifah Taufik	-
	An Nisaa Raihani Kamto	-

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Depok, 3 Juni 2024
Pengelola TPMB



Bdn.Ismi Santi S.ST



BIDAN ISMI SANTI S.ST
Gg. Inpres No.133 RT.003 RW.011
Kelapa Dua Kel. Tugu Kec.Cimanggis
Depok 16951, Telp: 081398112549



**Nama Anggota Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat
di TPMB Bdn Ismi Santi S.ST
Periode Juni-Agustus 2024**

Ketua Tim Pengusul	Nama	Bidang Ilmu
	Pujiati,S.Si.T.,M.Keb	Kebidanan
Anggota Pelaksana	Ambariani,SST.,M.Keb	Kebidanan
	Rini Damayanti, S.ST.,MPH	Kebidanan, Kesehatan Masyarakat
	Afifah Taufik	-
	An Nissa Raihani Kamto	-

**Nama Anggota Pelaksana Kegiatan Program
Pengabdian Masyarakat di TPMB. Ny. Ismi Santi
Tahun 2024**

Ketua Tim Pengusul	Nama	Bidang Ilmu
	Pujiati, M.Keb	Kebidanan
Anggota Pelaksana	Ambariani, M.Keb	Kebidanan
	Rini Damayanti, S.ST., MPH	Kebidanan, Kesehatan Masyarakat
	Afifah Taufik	Kebidanan
	An Nisaa Raihani Kamto	Kebidanan

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian						
		3	4	5	6	7	8
1	Koordinasi dengan pihak terkait						
2	Pengumpulan data dan informasi						
3	Analisis Kebutuhan Mitra						
4	Pelaksanaan Kegiatan						
5	Penyusunan Laporan Kegiatan						

LAMPIRAN 5. ANGGARAN BIAYA

NO.	KETERANGAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA	TOTAL
1.	Administrasi	Paket	0	0	0
2.	Transport	Kali	5	100000	500000
3.	Lumpsum				
	Makan	Unit			0
	Minum	Buah	20	25000	50000
	Snack	Buah	20	35000	700000
	buah	piring	5	100000	300000
4.	Kegiatan				0
	Ruang	Buah			0
	Modul	Buah			0
	Bahan	Buah	1	125000	125000
	Publikasi	Artikel	1	300000	300000
	Brosur	Buah	20	3000	60000
					2.035.000

LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

No	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
1	Afifah Taufik		Kebidanan
2	An Nisaa Raihani Kamto		Kebidanan

LAMPIRAN 7. LUARAN (PHOTO HASIL KEGIATAN)



